



Aturan Dasar ICD 10 Tahun 2010

RS Sardjito, 17-20 Juni 2026

Pusat Pembiayaan Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

HASIL BELAJAR



Setelah mengikuti mata
pelatihan ini, peserta
mampu melakukan
kodifikasi penyakit dan
masalah kesehatan lainnya
sesuai ICD 10 Tahun 2010



INDIKATOR HASIL BELAJAR



**Menjelaskan aturan dasar ICD-10
Tahun 2010**



**Melakukan koding morbiditas sesuai
aturan ICD-10 Tahun 2010**





1

**Aturan Dasar
ICD 10 Th 2010**

2

**Definisi, Tujuan,
Penggunaan ICD**

3

Struktur ICD 10

4

**Konvensi Tanda
Baca**

5

**Langkah Penentu
Koding ICD 10**

6

**Koding Morbiditas
Sesuai Aturan ICD 10**



Rugi Ratusan Juta Rupiah Perbulan, Bupati Takalar Tutup Sementara Layanan Kesehatan RS Galesong

Acwank [Wisata Takalar](#)
April 23, 2025 663 Dilihat

Referensi :
<https://sulselberita.com/2025>
<https://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI/article/download/1436/956/6395859>

JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.8 No.2, Agustus 2023, pp. 175-182
ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print)
<http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI>



Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Terhadap Status Klaim JKN Rawat Inap di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta

Tabel 2. Klaim JKN di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta

Klaim JKN	Jumlah	Persentase (%)
Diterima	104	83,2%
Pending	21	16,8%
Jumlah	125	100%

Ketidaktepatan penetapan kode diagnosis dapat berdampak pada terhambatnya pembiayaan asuransi yang dapat berakibat pada pengelolaan berkas rekam medis [3]. Dampak lainnya dari ketidaktepatan penetapan kode diagnosis yang diinput pada aplikasi INA-CBGs dalam proses klaim JKN dapat berdampak pada terjadinya pembayaran tarif pelayanan lebih tinggi (*upcoding*) yang dapat berakibat terjadinya *fraud* dan pembayaran tarif pelayanan lebih rendah (*down coding*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi rumah sakit [5].

DEFINISI ICD 10

01

ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)

02

ICD memuat klasifikasi diagnostik penyakit dengan standar internasional yang disusun berdasarkan sistem kategori dan dikelompokkan dalam satuan penyakit dan masalah kesehatan lainnya menurut kriteria tertentu yang telah disepakati pakar internasional



Definisi

Penyakit yang dikelompokkan atau dibuat dalam grup yang kriterianya sudah ditentukan

Contoh Kriteria

- ★ Etiologi
- ★ Anatomi
- ★ Umur
- ★ patofisiologi
- ★ Tanda dan gejala
- ★ Prognosis



Tujuan Penggunaan ICD 10



Tujuan klasifikasi ICD 10

- Membuat catatan menjadi sistematis
- Membantu penganalisisan
- Menerjemahkan dan membandingkan peristiwa penyakit dan kematian yang telah dikumpulkan di berbagai tempat, negara pada saat yang berlainan

Kegunaan ICD-10

- Sebagai sarana penterjemah diagnosis penyakit dan masalah kesehatan dari bentuk kata menjadi kode atau sandi alfanumerik sehingga memudahkan untuk disimpan, dicari dan kemudian dianalisis
- Dasar pengelompokan DRGs untuk pembayaran

DASAR HUKUM PENGUNAAN ICD DI INDONESIA



- Penggunaan ICD-10 SK Dirjen Pelayanan Medik No.H.K.00.06.1.4.00744 tentang Penggunaan Klasifikasi Internasional Mengenai Penyakit Revisi ke-10 di Rumah sakit tanggal 19 Februari 1996. Mulai dipakai di rumah sakit bulan April 1996 dan paling lambat Januari 1997
- Standar Akreditasi Bidang Rekam Medis S.5.P5. mengenai penggunaan buku ICD 10
- PMK No.26 Tahun 2021 tentang Pedoman INACBG dalam pelaksanaan JKN



3 VOLUME ICD 10



Volume 1
TABULAR LIST



Volume 2
Aturan manual



Volume 3
Alphabetical Index

RULES & GUIDELINES



VOLUME I ICD 10

1

- Pendahuluan
- Pusat Kolaborasi WHO untuk Klasifikasi Penyakit
(WHO Collaborating centers for Classification Diseases)



3

- Daftar tabular (22 Bab)
- Morfologi Neoplasma



2



- Laporan konferensi internasional untuk Revisi Kesepuluh Klasifikasi Internasional Penyakit
- Daftar kategori tiga karakter

- Daftar tabulasi khusus untuk Mortalitas dan Morbiditas
- Definisi
- Regulasi terkait Nomenklatur



4

CHAPTER ICD-10 A00 – U99

BAB	BLOCK		KATEGORI
1	A - B	A00 - B99	Penyakit Infeksi & Parasitik Tertentu
2	C	C00 - D48	Neoplasma
3	D	D50 - D89	Penyakit Darah & Organ Pembuat Darah
4	E	E00 - E96	Penyakit Endokrin, Nutrisi & Metabolik
5	F	F00 - F99	Gangguan Mental & Perilaku
6	G	G00 - G99	Penyakit Sistem Saraf
7	H	H00 - H59	Penyakit Mata & Adneksa
8	H	H60 - H95	Penyakit Telinga & Pros. Mastoideus
9	I	I00 - I99	Penyakit Sistem Sirkulasi Darah
10	J	J00 - J99	Penyakit Sistem Napas
11	K	K00 - K96	Penyakit Sistem Cerna
12	L	L00 - L99	Penyakit Kulit & Jaringan Subkutan
13	M	M00 - M99	Penyakit Sistem Muskuloskeletal
14	N	N00 - N99	Penyakit system Kemih
15	O	O00 - O99	Kehamilan, Persalinan & Masa Nifas
16	P	P00 - P96	Kondisi – Kondisi Tertentu
17	Q	Q00 - Q99	Kelainan Bawaan
18	R	R00 - R99	Gejala, Tanda (penemuan lab)
19	S – T	S00 - T98	Cedera & Keracunan
20	V – Y	V01 - Y98	Penyebab Luar
21	Z	Z00 - Z99	Faktor yg mempengaruhi Kesehatan dan kontak dengan pelayanan Kesehatan
22	U	U00 – U99	Kode - Kode untuk tujuan tertentu

DAFTAR TABULASI TINGKAT BAB

Sebagian besar Bab berkaitan dengan sistem-sistem tubuh

Contoh:



Sistem kardiovaskuler (I00-I99)



Sistem respiratori (J00-J99)



Sistem digestif (K00-K93)



Sistem genitourinary (N00-N99)

DAFTAR TABULASI TINGKAT BAB (Lanjutan-1)

Bab-Bab yang terkait penyakit khusus



**Penyakit infeksi & Parasitik (A,B)
(A00-B99)**



Neoplasma (C,D) (C00-D48)



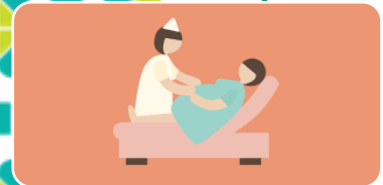
Anomali kongenital (Q00-Q99)

DAFTAR TABULASI TINGKAT BAB (Lanjutan-2)

Bab XV (O) khusus untuk gangguan pada:



Pregnancy (Kehamilan)



Childbirth (Persalinan-Kelahiran)



Puerperium (Masa nifas)

Bab XVI (P)



Certain conditions originating in the
perinatal period



Three-character categories

CHAPTER I

Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)

BLOCK

Intestinal infectious diseases (A00-A09)

3rd-character

A00	Cholera
A01	Thypoid and parahyphoid fever
A02	Other salmonella infections
A03	Shigellosis





Four-character subcategories

CHAPTER II

Neoplasms (C00-D48)

Malignant Neoplasms (C00-C97)

Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx (C00-C14)

C00

4th-character

- C00.0 Malignant neoplasm of lip External upper lip External lower lip
- C00.1 External lip, unspecified
- C00.2





ICD 10 Disease Classification

FIFTH CHARACTER

Chapter XIII

Anatomical site (Penyakit Sistem Otot & Tulang & Jaringan Lunak)

Chapter XIX

Untuk indikasi patah tulang terbuka dan tertutup, cedera intrakranial, intratoraks dan intraabdomen dengan atau tanpa luka terbuka

Chapter XX

Untuk mengetahui jenis aktivitas yang dilaksanakan pada suatu waktu dari kejadian



BUKU ICD-10, VOLUME 2

Volume 2 merupakan aturan manual atau pedoman tentang cara menggunakan volume 1 dan 3

ISI BUKU ICD-10, VOLUME 2:

- 01 Pendahuluan
- 02 Uraian Klasifikasi Statistik Internasional mengenai Penyakit dan Masalah Kesehatan Terkait
- 03 Cara menggunakan ICD
- 04 Aturan dan Pedoman Pengkodean Kematian dan Morbiditas
- 05 Presentasi statistik
- 06 Sejarah perkembangan ICD



Buku ICD-10, Volume 3

Volume 3 disebut Alphabetical Index (Indeks abjad) yang berfungsi sebagai Kamus'-nya volume 1

VOLUME 3 TERDIRI DARI 3 SEKSI

Seksi 1

Merupakan **Indeks Alphabet** dari penyakit dan perlukaan yang alami

Seksi 2

Merupakan **sebab luar** dari perlukaan dan memuat istilah dari bab XX Volume I

Seksi 3

Merupakan **tabel obat-obatan dan zat kimia**, sebagai sambungan dari bab XIX dan XX serta menjelaskan indikasi kejadiannya



STRUKTUR INTI KODE ICD-10 (Lanj. 3)

KARAKTER I BAB I – XXI □ Rev II (XXII)

A - Z

BLOK

H60 – H62

H65 – H75

H80 – H83

H90 – H95

(Diseases of external ear)

3 KARAKTER

H60

H61

dst

H69

(Otitis externa)

4 KARAKTER

H60.0

H60.1

dst

H60.9

(Abscess of external ear)

5 KARAKTER

S02.10

S06.21

dst

T14.21

(Fracture of base of skull closed)

5. KARAKTER

M00.01

M02.22

dst

M99.99

(Staphylococcal arthritis and polyarthritis ,
Shoulder region)

KONVENSI **KLASIFIKASI STATISTIK INTERNASIONAL TENTANG PENYAKIT DAN MASALAH TERKAIT KESEHATAN**



ICD-10

PARENTHESES ()

- ★ Menutup kata-kata tambahan
- ★ Menutup term exclusion
- ★ Menutup kategori 3th karakter
- ★ Menutup kode dagger & asterisk

E.g.

★ I10 - Hypertension **(arterial) (benign) (essential) (malignant) (primary) (systemic)**

★ H01.0 Blepharitis

Excludes : Blepharoconjunctivitis **(H10.5)**

★ Diseases of the Eye and Adnexa **(H00-H59)**

CONVENTION
()

SQUARE BRACKETS = []

**Menutup synonym, kata-kata alternatif
atau ungkapan penjelasan**

Untuk merujuk ke catatan sebelumnya

E.g.

- **A30 Leprosy [Hansen's Disease]**
- **C00.8 Overlapping Lesion of Lip**
[See note 5 on p. 182]
- **K27 Peptic Ulcer, site unspecified**
[See page 566 for subdivisions]

CONVENTION
[]

COLON = :

Kata-kata yg diikuti oleh 'colon' adalah term yg tidak lengkap

Koder harus melengkapi term dengan satu '**modifiers**'

E.g.

K36 Other Appendicitis

Appendicitis :

- Chronic
- Recurrent

CONVENTION
:

BRACE = }

Kata-kata sesudah 'brace' lengkap

Setiap term sebelum 'brace' harus di kualifikasi oleh satu / lebih terms yang mengikuti

E.g.

O71.6 Obstetric Damage to Pelvic Joints and Ligaments

Avulsion of inner symphyseal cartilage	}	
Damage to coccyx	}	obstetric
Traumatic separation of symphysis (pubis)	}	

CONVENTION
}

POINT DASH = .-

Kode subcategory diganti dengan (-)
Menunjukkan 'fourth character' eksis (ada)

E.g.

**G03 Meningitis due to other and
unspecified causes**

Excludes : Meningoencephalitis (G04._)

CONVENTION
.-

SEE” and “SEE ALSO

(petunjuk yang harus diikuti untuk mencegah kesalahan)

E.g.

- **Inflammation**
 - bone (see Osteomyelitis)
- **Paralysis**
 - shaking (see also Parkinsonism) G20
- **Enlargement, enlarged**
 - (see also Hypertrophy)

CONVENTION
SEE” and “SEE ALSO

“AND” pada judul suatu kode

Dalam judul makna kata “**and**” (dan) mewakili “**and/or**” (dan/atau)

S49.9 Unspecified of injury of shoulder and upper arm berarti:

- Unspecified injury of shoulder or
- **Unspecified injury of upper arm or**
- Unspecified injury of shoulder and upper arm

CONVENTION (NOS)

NOT OTHERWISE SPECIFIED (NOS)



- ★ Sama artinya dengan *Unspecified* atau *Unqualified*
- ★ Hanya digunakan apabila **tidak adanya informasi** untuk bisa digunakan sebagai penentu kode yang spesifik.

Contoh:

**K14.9 Disease of tongue unspecified
Glossopathy NOS**

NOT ELSEWHERE CLASSIFIED (NEC)

CONVENTION (NEC)

- ★ Digunakan sebagai **warning** (peringatan) bahwa ada tipe khusus satu kondisi yang terkode dan muncul di bagian / bab lain dari sistem klasifikasi ini.
- ★ Apabila **informasi spesifik** bisa ditemukan, maka akan bisa dipilihkan kode yang baik/tepat.
- ★ **Contoh: K73 Chronic hepatitis, NEC**

ISTILAH INCLUSION (TERMASUK/SINONIM)

- ★ Umumnya ada pada **Kategori 4-karakter**, bisa juga ada di **bawah Blok** atau **Bab**.
- ★ Contoh-contoh kondisi berbeda-beda atau **sinonim** dari kondisi yang terkode pada kategori terkait.
- ★ **Bukan suatu subklasifikasi**
- ★ Panduan isi kategori tidak mendalam dan lengkap

**CONVENTION
INCLUSION**

Contoh Inklusi (*Includes*) :

E10 Insulin-dependent diabetes mellitus

[See before E10 for subdivisions]

Includes: diabetes (mellitus):

- brittle
- juvenile-onset
- ketosis-prone
- type I

I11 Hypertensive heart disease

Includes: any condition in [I50.-](#), [I51.4-I51.9](#) due to hypertension

I11.0 Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure
Hypertensive heart failure

I11.9 Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure
Hypertensive heart disease NOS

I12 Hypertensive renal disease

Includes: any condition in [N00–N07](#), [N18.-](#), [N19](#) or [N26](#) due to hypertension
arteriosclerosis of kidney
arteriosclerotic nephritis (chronic)(interstitial)
hypertensive nephropathy
nephrosclerosis

ISTILAH EXCLUSION (TIDAK TERMASUK)

Terdiri dari daftar kondisi yang *harus dikode di tempat lain*, dan *tidak dikode dengan nomor kode kategori ini*, namun dikode dengan kode yang benar yakni *kode yang tersedia di dalam kurung ()*

Mengikuti istilah gangguan (penyakit) yang tertera di depan kurung tersebut.

CONVENTION
EXCLUSION

Contoh Eksklusi (*Excludes*) :

A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin

Note: In countries where any term listed in [A09](#) without further specification can be assumed to be of noninfectious origin, the condition should be classified to [K52.9](#).

Catarrh, enteric or intestinal

Colitis	}	
Enteritis	}	NOS, haemorrhagic, septic
Gastroenteritis	}	

Diarrhoea:

- NOS
- dysenteric
- epidemic

Infectious diarrhoeal disease NOS

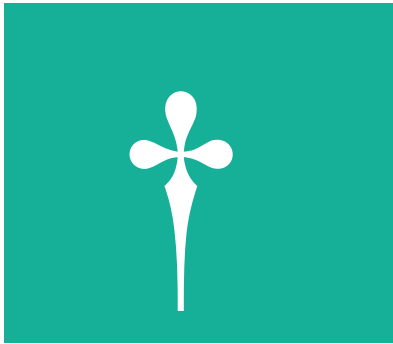
Excludes: due to bacterial, protozoal, viral and other specified infectious agents ([A00–A08](#))
noninfective diarrhoea ([K52.9](#))
• neonatal ([P78.3](#))

PENGUNAAN KODE DAGGER DAN ASTERISK





Sistem 'dagger' dan 'asterisk'



Sistem ini memakai **kode utama** bertanda dagger (†) untuk **diagnosis penyakit umum yang merupakan penyakit dasar**, dan **kode tambahan** bertanda **asterisk (*)** untuk akibatnya pada organ atau tempat tertentu yang merupakan masalah tersendiri (penyakit tambahan)





Sistem 'dagger' dan 'asterisk'



Dagger harus selalu dipakai (bisa berdiri sendiri)



Asterisk dipakai kalau nama alternatif juga diperlukan **Untuk pengkodean, asterisk tidak boleh dipakai sendirian**





Sistem 'dagger' dan 'asterisk'



Sistem ini memiliki 83 kategori asterisk yang dinyatakan di awal bab. Rubrik-rubrik yang bertanda **dagger** bisa memiliki satu di antara tiga bentuk berikut:



- I. Kalau **dagger** dan **asterisk** terdapat pada **judul rubrik**, maka **semua nama** pada rubrik tersebut **memiliki klasifikasi kembar dan kode tambahan yang sama, misalnya:**

A17.0† Tuberculous meningitis (G01 *) Tuberculosis of meninges (cerebral)(spinal) Tuberculous leptomeningitis



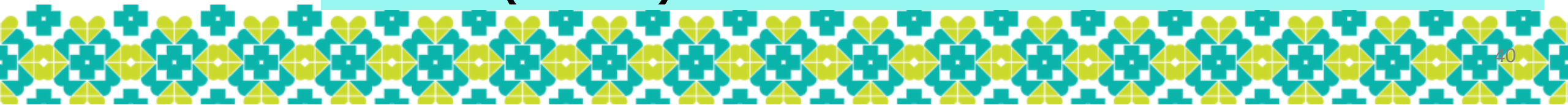


- II. Kalau **dagger terdapat** pada judul rubrik tapi **asterisk tidak ada**, maka semua nama pada rubrik tersebut memiliki **klasifikasi kembar** tapi kode tambahannya **berbeda**. Kode tambahan ini dituliskan untuk setiap nama, misalnya:

A18.1† Tuberculosis of genitourinary system

Tuberculosis of:

- bladder (N33.0 *)
- cervix (N74.0 *)
- kidney (N29.1 *)
- male genital organs (N51.- *)
- ureter (N29.1 *)
- Tuberculous female pelvic inflammatory disease (N74.1 *)





Sistem 'dagger' dan 'asterisk'



III. Kalau dagger dan asterisk **tidak ada** pada judul, maka rubrik umumnya **tidak memiliki** kode tambahan, walaupun bisa terdapat nama inklusi tertentu. Pada tempat ini nama tersebut akan bertanda dagger dengan kode tambahan, misalnya:



A54.8 Other gonococcal infection

Gonococcal

- peritonitis † (K67.1 *)
- pneumonia † (J17.0 *)
- septicaemia
- skin lesions





PENGGKODEAN KEMBAR PILIHAN LAINNYA

Terdapat situasi selain di dalam dagger dan asterisk yang memungkinkan dua kode ICD dipakai untuk menguraikan suatu kondisi dengan jelas. Catatan pada daftar tabulasi yaitu **“Use additional code, if desired ...”**. Kode-kode tambahan ini hanya digunakan pada tabulasi-tabulasi khusus:

1. **Infeksi lokal** pada bab ‘**body systems**’, kode dari BAB I Blok kategori **B95-B97** bisa ditambahkan untuk identifikasi penyebab infeksi.

Contoh : *Pyothorax akibat infeksi staphylococcus*

kode ICD-10 : J86.9 B95.8

J86	Pyothorax	Bacterial, viral and other infectious agents (B95-B98)
------------	------------------	---

Includes: abscess of:
· pleura
· thorax
empyema
pyopneumothorax

Note: These categories should never be used in primary coding. They are provided for use as supplementary or additional codes when it is desired to identify the infectious agent(s) in diseases classified elsewhere.

Use additional code ([B95-B97](#)), if desired, to identify infectious agent.

Excludes: due to tuberculosis ([A15-A16](#))

B95.8 Unspecified staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters





2. **Neoplasma yang memiliki aktifitas fungsional**, kode dari bab II bisa ditambah dengan kode yang sesuai dari bab IV untuk menunjukkan aktifitas fungsionalnya.

Contoh	Malignant neoplasm of adrenal gland dengan adrenomedullary hyperfunction
ICD 10	C74.- E27.5

3. **Kode morfologi pada neoplasma**, ditambahkan untuk identifikasi jenis morfologis tumor tersebut.

Coded nomenclature for morphology of neoplasms

M800 Neoplasms NOS

M8000/0	Neoplasm, benign
M8000/1	Neoplasm, uncertain whether benign or malignant
M8000/3	Neoplasm, malignant
M8000/6	Neoplasm, metastatic





4. Untuk kondisi yang bisa diklasifikasikan pada F00-F09 (kelainan jiwa organik) pada bab V, satu kode dari bab lain bisa ditambahkan untuk menunjukkan penyebab, misalnya penyakit yang mendasari, cedera, atau gangguan lain terhadap otak.

Contoh	Dementia in Alzheimer Disease ICD 10 : G30.9+ F00.9*
--------	---

5. Kalau kondisi disebabkan oleh zat yang bersifat toksik, **sebuah kode dari bab XX bisa ditambahkan** untuk identifikasi zat tersebut.

Contoh	Drug-Induced Acute Hepatitis akibat Efek Samping OAT (Obat Anti-Tuberculosis)
ICD 10	K71.2, Y41.1

6. Dua kode bisa digunakan untuk menguraikan cedera, keracunan atau efek lain, kode dari **BAB XIX** yang menjelaskan bentuk cedera, dan kode dari bab **BAB XX yang menjelaskan penyebabnya**. Contoh:

Contoh	<u>Fracture</u> pada humerus <u>akibat jatuh</u> dari tempat tidur ketika sedang beristirahat di rumah.
ICD 10	S42.30 W06.04



Pengenalan dan Penggunaan **“LEAD TERMS & MODIFIER”**



Indeks vol III berisi :

'lead terms' Merupakan kondisi utama /diagnosa utama / kondisi patologis / nama penyakit / nama penemu penyakit

- Diletakkan pada bagian paling kiri,
- Untuk penyakit dan cedera ini biasanya berupa sebuah kata benda untuk kondisi patologis.
- Namun, beberapa kondisi yang berupa kata sifat atau eponim (nama orang) bisa juga terdapat disini.

('modifier' atau 'qualifier') Menunjukkan letak anatomi / menggambarkan suatu keadaan

- Pada Section I, modifier yang berindentasi (dimajukan ke kanan)
 - ini biasanya berupa jenis,
 - tempat, atau kondisi yang mempengaruhi kode
- pada Section II menunjukkan
 - berbagai jenis kecelakaan atau kejadian,
 - kendaraan yang terlibat, dsb. Modifier yang tidak mempengaruhi kode berada di dalam tanda kurung setelah kondisi yang tertulis.

Langkah - langkah untuk melakukan kodifikasi

1) Tentukan **jenis pernyataan (Diagnosa)** yang akan dikode dan rujuk ke Section yang sesuai pada Indeks Alfabet

2) Tentukan lokasi **'lead term,'**. Untuk penyakit dan cedera

3) **Baca dan pedomani** semua catatan yang terdapat di bawah 'lead term'

4) Baca semua **term yang dikurung oleh parentheses** setelah 'lead term'

5) Ikuti dengan **hati-hati setiap rujukan silang** 'see' dan 'see also' di dalam Indeks

6) **Rujuk daftar tabulasi (Volume I)** untuk memastikan nomor kode yang dipilih

7) Pedomani setiap term inklusi dan eksklusi di **bawah kode** yang dipilih, atau di bawah judul bab, blok, atau kategori

8) **Tentukan kode**

Contoh
Penentuan
'lead term,'

Acute Ulcer of the Stomach with
Haemorrhage and Perforation



Ulcer, ulcerated, ulcerating
- stomach (eroded)(peptic)(round)
- - acute
- - - with
- - - - hemorrhage
- - - - - and perforation □ K25.2



GOLDEN CODING RULES



Kategori **penyakit khusus** memperoleh **prioritas diatas** kategori sistem tubuh.

Contoh: Ca. Paru-Paru akan diklasifikasikan dalam bab II Neoplasma bukan dalam Bab X Penyakit Sistem pernafasan

Volume 1 dan 3 harus digunakan bersama-sama untuk menemukan kode yang benar dari setiap kasus



ATURAN KODING MORBIDITAS





DEFINISI & KEGUNAAN MORBIDITAS



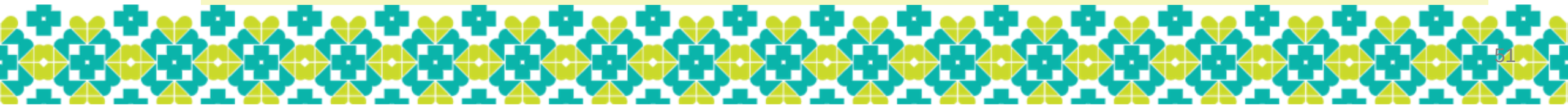
DEFINISI

- **Morbid** berasal dari bahasa Latin yang berarti **kondisi sakit atau menjadi sakit**
- **Morbiditas** adalah sebutan bagi
 1. kualitas penyakit atau yang sedang terserang sakit.
 2. Kondisi yang menyebabkan sakit.
 3. Ratio jumlah yang sakit dalam total populasi di komunitasnya



KEGUNAAN

- **Me-manage** pelayanan pasien
- **Merencanakan** pelayanan kesehatan
- **Alokasi** ketepatan sumber daya
- **Identifikasi** penyebab penyakit
- **Evaluasi** terapi
- **Mengkaji** proyek baru atau program kesehatan masyarakat



DEFINISI WHO TENTANG DIAGNOSIS

... “**diagnosis** adalah proses mengidentifikasi suatu penyakit atau kondisi medis berdasarkan gejala, tanda, riwayat kesehatan, dan hasil pemeriksaan kesehatan.”



Klasifikasi Diagnosis

Diagnosis

Diagnosis Utama

Diagnosis yang ditetapkan pada akhir episode perawatan yang menjadi alasan utama pasien menerima pengobatan / pemeriksaan..diagnosa yang paling bertanggungjawab atas episode pelayanan, jika terdapat lebih dari 1 diagnosa maka pilih satu yang paling utama

Diagnosis Sekunder

Diagnosis yang ikut bersama (co-exists) dengan diagnosis utama saat admisi, atau yang muncul dalam perawatan pasien

Diagnosa Komorbid

Diagnosa Komplikasi

Diagnosis Penyebab Luar

Kalau terdapat akibat penyebab eksternal seperti:

Cedera

Keracunan

Akibat lainnya

Sangat penting untuk dijelaskan secara lengkap bentuk kondisi itu dan kenapa kondisi itu terjadi dan Dimana terjadi

PEDOMAN PENCATATAN DIAGNOSIS



PEDOMAN PENCATATAN DIAGNOSIS

General

Kespesifikan dan Detail

Diagnosis atau Gejala tidak pasti

**Kontak dengan Pelayanan Kesehatan
untuk Alasan selain Sakit**

Kondisi Ganda (Multiple condition)

Kondisi Akibat Penyebab Eksternal

**Pengobatan Sekuel (Treatment of
Sequelae)**

GENERAL

01

Dokter yang bertanggung jawab atas pengobatan pasien harus memilih kondisi utama untuk dicatat, di samping kondisi lain, **untuk setiap episode asuhan kesehatan**

02

Informasi ini harus diatur secara sistematis menurut cara-cara pencatatan standard

03

Catatan yang diselesaikan sebagaimana mestinya penting untuk pengelolaan pasien secara baik dan merupakan sumber berharga untuk data epidemiologis dan statistik lainnya mengenai morbiditas dan masalah asuhan kesehatan lainnya.

Kespesifikan dan detail

Setiap pernyataan diagnosa harus seinformatif mungkin untuk bisa mengklasifikasikan kondisi pada kategori ICD yang paling spesifik

Contoh-contoh pernyataan diagnostik seperti :

1. Karsinoma sel transisional pada trigonum bladder C67.0 (M8120/3)
2. Appendisitis akut dengan perforasi
3. Katarak diabetes, tergantung insulin
4. Perikarditis meningokokus
5. Perawatan antenatal untuk hipertensi akibat kehamilan
6. Diplopia akibat reaksi alergi terhadap antihistamin yang dimakan sesuai resep
7. Osteoarthritis panggul akibat fraktur lama panggul
8. Fraktur leher femur setelah tejatuh di rumah
9. Luka tingkat tiga di telapak tangan

Diagnosis atau gejala yang tidak pasti

Jika tidak ada diagnosis pasti di akhir suatu episode asuhan kesehatan, maka harus dicatat informasi yang memberikan **kespesifikan dan pemahaman maksimum** mengenai kondisi yang menyebabkan perlunya perawatan dan pemeriksaan tersebut

Hal ini harus dilakukan dengan **menuliskan gejala, penemuan abnormal atau masalah**, ketimbang membuat diagnosis sebagai “mungkin”, “dipertanyakan” atau “diduga”, ketika diagnosis ini telah dipikirkan tapi tidak ditegakkan

KONTAK DENGAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK ALASAN SELAIN SAKIT

Kontak dengan pelayanan kesehatan tidak terbatas pada pengobatan atau pemeriksaan penyakit atau cedera saat itu saja

Episode bisa juga terjadi kalau seseorang yang mungkin tidak sakit memerlukan atau mendapatkan perawatan atau layanan terbatas; disini detil hal-hal yang relevan harus dicatat seolah-olah 'kondisi utama'

Contoh-contohnya antara lain adalah:

- monitoring kondisi yang diobati sebelumnya
- imunisasi
- pengelolaan kontrasepsi, perawatan antenatal atau postpartum
- pengawasan orang beresiko karena riwayat pribadi atau keluarga

Bab XXI (Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak dengan pelayanan kesehatan) berisi kategori yang luas (Z00-Z99) untuk mengklasifikasi hal-hal di atas; rujukan kepada Bab ini dapat menunjukkan detil yang diperlukan untuk memungkinkan klasifikasi mencapai kategori yang paling relevan.

KONDISI GANDA (Multiple Condition)

EPISODE ASUHAN MENCAKUP KONDISI YANG BERHUBUNGAN

Kalau suatu episode asuhan kesehatan mencakup sejumlah kondisi yang berhubungan (misalnya cedera ganda, sekuel ganda penyakit atau cedera sebelumnya, atau kondisi ganda yang terjadi pada penyakit human immunodeficiencyvirus [HIV]), salah satu yang jelas lebih berat dan lebih menuntut sumber-daya dibandingkan dengan yang lain dicatat sebagai '**KONDISI UTAMA**', dan yang lainnya sebagai '**KONDISI LAIN**'.

TIDAK ADA SATU KONDISI YANG MENONJOL

Kalau tidak ada satu kondisi yang menonjol, maka istilah seperti '**fraktur ganda**', '**cedera ganda kepala**', atau '**penyakit HIV yang menyebabkan infeksi ganda**' bisa dicatat sebagai **KONDISI UTAMA**, diikuti oleh sebuah daftar kondisi-kondisi. Kalau terdapat beberapa kondisi seperti itu tanpa ada yang menonjol, maka istilah seperti '**cedera ganda**' atau '**cedera hantaman ganda**' harus dicatat tersendiri.



PENGOBATAN SEKUEL (Treatment of sequelae)

Kalau suatu episode asuhan adalah untuk pengobatan atau pemeriksaan kondisi sisa (sekuel) suatu penyakit yang sudah tidak diderita lagi, maka **SEKUEL HARUS** dicatat sepenuhnya dan asal-usulnya dinyatakan, bersamaan dengan petunjuk jelas bahwa penyakit semula tidak lagi terdapat. Contoh

1. Septum hidung bengkok e.c fraktur hidung di masa kanak-kanak
2. Kontraktur tendon Achilles, efek jangka panjang dari cedera tendon
3. Infertilitas akibat penutupan tuba karena tuberkulosis masa lalu

Kalau terdapat sekuel ganda dan pengobatan atau pemeriksaan **TIDAK LEBIH** diarahkan pada salah satu di antaranya, maka pernyataan seperti 'sekuel' kecelakaan kardiovaskuler' atau 'sekuel fraktur ganda' bisa **DITERIMA**



ATURAN MORBIDITAS

PEDOMAN UNTUK PEMBERIAN KODE “KONDISI UTAMA” DAN “KONDISI LAIN”





PEDOMAN UNTUK PEMBERIAN KODE “KONDISI UTAMA” DAN “KONDISI LAIN”

1. Prinsip Umum (General Principal)

Penentuan kondisi utama & kondisi lain yang direkam oleh **PPA / Dokter** □ **memudahkan** proses pemberian **kode ICD**, karena keputusan tentang kondisi utama harus dicatat dan dikode serta diproses oleh coder, **kecuali bila panduan (ICD) tidak diikuti oleh para praktisi dokter.**

2. Kode Tambahan pilihan

- Pengkodean sistem **dagger asterisk**
- Pengkodean dugaan **kondisi gejala** dan penemuan abnormal dan situasi tanpa penyakit
- Pengkodean **kondisi ganda**
- Pengkodean kategori **kombinasi**
- Pengkodean **penyebab luar** morbiditas
- Pengkodean **sekuel** kondisi tertentu
- Pengkodean kondisi kondisi **akut dan kronis**
- Pengkodean kondisi **pasca prosedur dan komplikasinya**

3. Rule MB1 - MB 5

MB 1

minor-mayor → Mayor sebagai DU

MB 2

DU: a,b,c,d → pilih sesuai DPJP Utama

MB 3

Gejala dari DU → tetap dikoding

MB 4

Kespesifikan Kasus

MB 5

Diagnosa Alternatif bukan kode R



a. Pengkodean Kondisi Tempat Sistem Dagger dan Asterisk Bisa Digunakan

Kalau sesuai, kode-kode dagger dan asterisk harus digunakan untuk kondisi utama, karena mereka merupakan dua jalur berbeda pada suatu kondisi tunggal

Contoh 1:

- ✓ Kondisi utama : Pneumonia measles
- ✓ Kondisi lain : --
- ✓ Kode oleh : Measles yang diperberat pneumonia (B05.2†) dan pneumonia pada penyakit virus yang diklasifikasikan di bagian lain (J17.1 *)



b. Pengkodean Dugaan

Kondisi, gejala, dan penemuan abnormal; dan situasi tanpa penyakit

RAWAT INAP: Hati-hati klasifikasi kondisi utama (Bab XVIII & XXI)

Jika tidak ada penyakit/cidera spesifik → boleh pakai Bab XVIII dan XXI

Setelah Episode Asuhan: Jika masih 'diduga/ dipertanyakan' & tanpa info lanjut → Dikode seolah diagnosis sesungguhnya

Kategori Z03.-: Untuk observasi & evaluasi medis

Diagnosis dugaan yang bisa dibatalkan setelah pemeriksaan

● Contoh

✓ Kondisi utama : Pemeriksaan dugaan neoplasm ganas serviks – **ternyata**

✓ Kondisi lain **bukan** : - -

✓ Kode : Observasi dugaan neoplasma ganas (Z03.1)
sebagai 'KU'.





c. Pengkodean Kondisi Ganda

- ★ Kalau kondisi ganda dicatat di dalam kategori berjudul “**Multiple**”, dan tidak satu pun kondisi yang menonjol → kode untuk kategori “**Multiple**”, harus dipakai sebagai kode utama, dan kode tambahan bisa diberikan untuk setiap kondisi.
- ★ Pengkodean seperti ini digunakan terutama pada kondisi yang berhubungan dengan penyakit HIV, cedera dan sekuel.





d. Pengkodean Kategori Kombinasi

- ✓ ICD menyediakan kategori untuk dua kondisi atau kondisi + proses sekunder yang berhubungan dalam satu kode
- ✓ Kategori kombinasi digunakan sebagai kondisi utama.
- ✓ Indeks alfabetis (Vol. 3) menunjukkan kombinasi dengan istilah 'with'.
- ✓ Dua kondisi atau lebih dapat digabung jika satu kondisi mengubah sifat kondisi lain.

● Contoh

- | | |
|-----------------|---|
| ✓ Kondisi utama | Gagal ginjal |
| : | Penyakit ginjal hipertensi |
| ✓ Kondisi lain | : Penyakit ginjal hipertensi dengan gagal ginjal (I12.0) sebagai 'KU'. |
| : | |





e. Pengkodean Penyebab Luar Morbiditas

- ✓ Untuk cedera/kondisi akibat sebab eksternal, baik kondisi maupun kejadian di sekitar sebab eksternal harus dikode.
- ✓ Kode utama ('KU') harus menjelaskan kondisi.
- ✓ Kode tambahan dari Bab XX dipakai untuk penyebab eksternal.

● Contoh

- ✓ Kondisi utama : Fraktur leher femur karena jatuh akibat tersandung di jalan tidak rata
- ✓ Kondisi lain : Kontusio siku dan lengan atas
- ✓ Kode penyebab : **Fraktur leher femur (S72.00)** sebagai 'KU'. Kode eksternal untuk **jatuh pada ketinggian yang sama akibat**

tergelincir, tersandung atau jatuh di jalan (W01.4 [9]) dapat digunakan sebagai kode tambahan pilihan.



f. Pengkodean sekuel kondisi tertentu

ICD menyediakan sejumlah kategori yang berjudul “sequelae of ...” (**B90-B94, E64.-, E68, G09, I69.-, O97, T90-T98, Y85-Y89**) yang digunakan untuk menunjukkan kondisi yang tidak didapatkan lagi, sebagai penyebab masalah yang saat ini sedang diperiksa atau diobati. Namun, kode yang diutamakan sebagai ‘KU’ adalah kode yang sesuai dengan bentuk sekuel itu. Kode “sequelae of.....” dapat ditambahkan sebagai kode tambahan.

Kalau terdapat sejumlah sekuel spesifik namun tidak ada yang lebih menonjol dalam hal kegawatan dan penggunaan sumber, boleh digunakan “Sequelae of ...” sebagai ‘KU’, yang kemudian dikode pada kategori yang sesuai. Perhatikan bahwa kondisi penyebab bisa dinyatakan dengan istilah ‘old’ (lama), ‘no longer present’ (tidak terdapat lagi), dan sebagainya,. begitu pula kondisi yang diakibatkannya bisa dinyatakan sebagai ‘late effect of’ (efek lanjut), atau ‘sequela of’. Tidak diperlukan interval waktu minimal.

- Contoh
- Kondisi utama : Efek lanjut poliomyelitis
- Kondisi lain : -
- ✓ Kode : Sequelae of poliomyelitis (B91) sebagai ‘kondisi utama’ karena informasi lain tidak

tersedia.





g. Pengkodean Kondisi-Kondisi Akut dan Kronis

Kalau kondisi utama dicatat sebagai akut (atau subakut) dan kronis, dan ICD menyediakan kategori atau subkategori yang berbeda untuk masing-masing, tapi tidak untuk gabungannya, kategori kondisi akut harus digunakan sebagai kondisi utama.

● Contoh 1

➤ Kondisi utama : Kholesistitis akut dan kronis

➤ Kondisi lain : -

✓ Kode : **Acute cholecystitis (K81.0)** sebagai 'KU'.

Kode ' chronic

cholecystitis (K81.1) bisa sebagai kode tambahan pilihan.

● Contoh 2

➤ Kondisi utama : Penggawatan akut bronkitis kronis obstruktif.

➤ Kondisi lain : -

✓ Kode : **Chronic obstructive pulmonary disease with acute**

exacerbation (J44.1) sebagai 'KU' karena disini terdapat kode gabungan akut dan kronis.



h. Pengkodean Kondisi Pasca-Prosedur dan Komplikasinya



Bab XIX (T80-T88) berisi kategori komplikasi akibat operasi/prosedur lain.

- Infeksi luka operasi
- Komplikasi mekanis implantasi
- Syok, dll.



- ★ Hampir semua bab tubuh juga berisi kategori kondisi akibat prosedur/teknik tertentu atau akibat pembuangan organ.
- ★ Kondisi setelah prosedur (misalnya pneumonia, embolisme paru) tidak dianggap sebagai kondisi sendiri → dikode seperti biasa + kode tambahan Y83-Y84.
- ★ Jika komplikasi dicatat sebagai kondisi utama → rujuk ke 'modifier' atau 'qualifier' pada Indeks Alfabet.





3. RULE MB 1 - MB 5

Apabila mungkin, rekam medis yang berisi penulisan yang tidak konsisten atau salah perekaman kondisi utama, kembalikan ke dokternya untuk klarifikasi. Apabila klarifikasi tidak dapat terlaksana maka terapkan rule MB1 sampai dengan MB 5



RULE MB1

Kondisi minor direkam sebagai “Kondisi utama” (main condition), kondisi yang lebih bermakna direkam sebagai “kondisi lain” (other condition)

- pilih kondisi yang relevan sebagai “Kondisi utama”

CONTOH RULE MB I



KASUS Bedah	No RM :xxxxxxx	RESELEKSI KONDISI UTAMA RULE MB 1	
	J.Kel : P Umur : 59 TH Kelas : III		
Diagnosis Utama	Arthritis Reumatoid		Hernia Femoralis Strangulata K41.3
Diagnosis Lain	▪ Diabetes mellitus ▪ Hernia femoralis strangulata ▪ Arteriosklerosis generalisata		▪ Diabetes mellitus ▪ Arthritis reumatoid ▪ Arteriosklerosis generalisata
Tidakkan/Operasi	▪ Herniorraphy ▪ Pem Lab Darah		▪ Herniorraphy ▪ Pem Lab Darah
Bidang Khusus	Spesialisasi Bedah		
LOS	14 Hari		

Kembalikan ke-dokternya untuk KLARIFIKASI

RULE MB 2

CONTOH RULE MB 2



Beberapa Kondisi yang direkam sebagai kondisi utama:

Beberapa kondisi tidak bisa dikode bersama dan jadi kondisi utama semua, ada 1 kondisi yang merujuk sebagai **kondisi utama**, maka pilih ini sebagai **kondisi utama**, bila tidak ada maka pilih yang **pertama disebut**.

KASUS Neurologi	No RM :xxxxxx	RESELEKSI KONDISI UTAMA RULE MB 2	
	J.Kel : P Umur : 50 TH Kelas : III		
Diagnosis Utama	▪ Katarak ▪ Meningitis Stafilokokkal ▪ Penyakit Jantung Iskemik		Meningitis Stafilokokkal G00.3
Diagnosis Lain	-		▪ Katarak ▪ Penyakit Jantung Iskemik
Tindakan/Operasi	- Lab darah		- Lab darah
Bidang Khusus	Spesialisasi Neurologi		
LOS	35 Hari		

Kembalikan ke-dokternya untuk KLARIFIKASI

RULE MB 3

CONTOH RULE MB 3



kondisi utama menggambarkan suatu gejala (Bab XVIII (R.-)) yang timbul akibat suatu diagnose atau kondisi yang ditangani namun dalam rekam medis ada kondisi lain yang lebih menggambarkan diagnosis pasien dan ada terapi diberikan. maka **reseleksi kondisi akhir** tersebut sebagai kondisi utama.

KASUS Urologi	No RM :xxxxxx	RESELEKSI KONDISI UTAMA RULE MB 3	
	J.Kel : L Umur : 45 TH Kelas : III		
Diagnosis Utama	- Hematuria		Papillomata pada dinding belakang kandung kencing D41.4
Diagnosis Lain	▪ Varices Vena Tungkai Bawah ▪ Papillomata pada dinding belakang kandung kencing		▪ Hematuria? ▪ Varices Vena Tungkai Bawah
Tidakn/Operasi	▪ Eksisi diatermi dari papillomata		Eksisi diatermi dari papillomata
Bidang Khusus	Spesialisasi Urologi		
LOS	12 Hari		

Kembalikan ke-dokternya untuk KLARIFIKASI

RULE MB 4

Specificity (Kekhususan)

Bila diagnosis utama adalah istilah yang umum, dan ada istilah lain yang memberi informasi lebih tepat tentang lokasi tubuh atau sifat dasar suatu kondisi, maka

reseleksi kondisi terakhir sebagai kondisi utama

Contoh MB4

- MB4

Kondisi utama	: Congenital heart disease	(UMUM)
Kondisi lain-lain	: Ventricular septal defect	(SPESIFIK)

Reseleksi	: Ventricular septal defect
-----------	-----------------------------

(Q21.0) (Ventricular septal defect lebih spesifik dari congenital heart disease)

Kembalikan ke-dokternya untuk KLARIFIKASI

RULE MB 5

Alternatif diagnoses utama

Suatu tanda/gejala sebagai kondisi utama, dengan indikasi kondisi terkait disebabkan suatu kondisi lain, reseleksi gejala tersebut sebagai “**kondisi utama**”

Bila ada 2 atau > dari 2 kondisi direkam sebagai pilihan diagnostik sebagai kondisi utama, pilih yang pertama disebut

CONTOH RULE MB 5



KASUS Saraf	No RM :xxxxxxx	RESELEKSI KONDISI UTAMA RULE MB 5	
	J.Kel : P Umur : 32 TH Kelas : III		
Diagnosis Utama	▪ Sakit kepala mungkin karena sinusitis atau stres.		▪ Sakit kepala R51
Penyebab Lain	-		▪ Penatalaksanaan Lebih Lanjut ▪ Konsul sub-lain
Tidakcan/Operasi	▪ -		-
Bidang Khusus	Neurologi		
LOS	Rawat Jalan		

Kembalikan ke-dokternya untuk KLARIFIKASI

EVALUASI ATURAN KODING MORBIDITAS

GOLDEN RULES

Volume 1 dan 3
harus digunakan
bersama

MAIN & OTHER

Tentukan kondisi
utama dan sekunder

LANGKAH

Pedomani Langkah
Penentuan Koding

KONVENSI

Pedomani & Perhatikan
konvensi/tanda baca

RULE MB

Pahami
Rule MB1 - 5

KESIMPULAN



KESIMPULAN

...Ketepatan koding diagnosis dan tindakan/prosedur sangat berpengaruh terhadap hasil grouper dalam aplikasi pembiayaan kesehatan...

Maka KODER harus melakukan koding sesuai dengan ATURAN KODING ICD



Referensi

WHO, ICD-10 Volume I, II, III Tahun 2010



TERIMA KASIH

